

Aquablation (Chirurgie de la prostate par jet d'eau)

Information pour le patient · Traitement sans chaleur, guidé par imagerie, pour une prostate hypertrophiée

WARWIKI

L'Aquablation est une chirurgie récente pour l'hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) qui utilise un **jet d'eau sous pression, sans chaleur**, guidé par échographie et introduit par l'urètre, pour retirer avec précision le tissu qui gêne l'écoulement de l'urine. Elle vise à lever l'obstruction tout en préservant mieux la fonction sexuelle — les études montrent qu'elle provoque **moins d'éjaculation rétrograde** que la résection transurétrale de la prostate (RTUP).

À propos de cette intervention

À l'aide d'un endoscope et d'une image **échographique** en temps réel de votre prostate, le chirurgien cartographie précisément le tissu à retirer. Un **jet d'eau commandé par robot** retire ce tissu avec précision, sans chaleur. Une brève étape de cautérisation contrôle le saignement, puis une sonde est mise en place.

Pourquoi choisir l'Aquablation

- **Guidée par imagerie et précise**, elle convient à différentes tailles de prostate (y compris les plus volumineuses)
- Amélioration du débit urinaire **comparable à la RTUP**
- Conçue pour **préserv**er l'**éjaculation** mieux que la RTUP

C'est une option relativement récente ; les données à très long terme continuent de s'accumuler.

COMPRENDRE LES TERMES

Aquablation

Ablation par jet d'eau du tissu prostatique pour traiter l'HBP.

HBP

Hypertrophie bénigne (non cancéreuse) de la prostate.

Sans chaleur

Utilise la pression de l'eau, pas la chaleur, pour retirer le tissu.

Guidé par échographie

Une image en direct permet au chirurgien de cibler exactement la zone à traiter.

Éjaculation rétrograde

Orgasme sec — moins fréquent après l'Aquablation qu'après la RTUP.

Sonde

Tube drainant la vessie pendant un jour ou deux après l'intervention.

EN QUOI EST-CE DIFFÉRENT DE LA RTUP ? Elle retire le tissu prostatique avec un **jet d'eau précis, sans chaleur, guidé par échographie** plutôt qu'avec une anse électrique. Les résultats sur le débit urinaire sont similaires à ceux de la RTUP, mais les chances de **préserver l'éjaculation** sont meilleures. En contrepartie, la technique est plus récente avec moins de données à long terme, et le saignement est contrôlé par une brève cautérisation.

Comment vous préparer

- Réalisée sous **anesthésie générale ou rachianesthésie** — respectez les consignes de jeûne et les instructions concernant vos médicaments (suspendez les anticoagulants selon les indications).
- Un **examen d'urine** est réalisé au préalable pour écarter toute infection.
- Prévoyez un accompagnateur ; la sonde est retirée rapidement.

Déroulement & Après

- 1 Vous êtes endormi ou insensibilisé ; des antibiotiques sont administrés.
- 2 L'échographie cartographie la prostate et le chirurgien planifie la zone à traiter.
- 3 Le jet d'eau retire le tissu ; une brève étape contrôle le saignement.
- 4 Une sonde est mise en place, généralement retirée en **1 à 2 jours** ; une nuit d'hospitalisation est souvent prévue.

Attendez-vous à des **urines teintées de sang** et à quelques brûlures ou urgences mictionnelles pendant quelques semaines ; buvez suffisamment et évitez les efforts et les charges lourdes.

Appelez votre équipe soignante si vous avez :

- Une **impossibilité d'uriner** après le retrait de la sonde
- Un **saignement abondant ou des caillots** obstruant l'écoulement
- De la fièvre ou des frissons
- Un saignement qui s'aggrave au lieu de diminuer

TROIS CHOSES À RETENIR

1. L'Aquablation retire le tissu prostatique obstructif par un jet d'eau précis, sans chaleur, guidé par échographie via l'urètre.
2. Les résultats sur le débit sont comparables à ceux de la RTUP, avec de meilleures chances de **préserver l'éjaculation** ; les données à long terme sont encore en cours de collecte.
3. La sonde est retirée rapidement. Contactez votre équipe en cas d'impossibilité d'uriner, de saignement abondant ou de fièvre.